

KC桌面——外资精译

MS：ErascaInc.

在近期 ERAS-0015 更新反映其特性增强及注册路径更清晰后，但仍维持等权重评级，等待更成熟和持久的数据。ERAS 在竞争激烈的 RAS 领域中似乎处于有利地位。

渐进式进展，但有待进一步验证。近期更新提高了差异化、多适应症注册机会的可见度，但我们仍维持等权重评级，等待更成熟的数据和更长的随访期。最初的 ERAS-0015 更新凸显了潜在同类最佳的特性，但研究逻辑仍依赖于一个规模较小、处于早期阶段的 1 期数据集、一个新兴的联合用药信号，以及从扩展研究到注册的演变路径。最新数据开始回应这些要素。随着更多患者加入和随访时间延长，疗效得以维持，在某些情况下甚至有所改善；在标准剂量下已证明早期联合用药的可行性；管理层已勾勒出更清晰、更快速的路径，以进入注册性研究。即将公布的数据，包括 2026 年下半年 ERAS-4001 初步 1 期单药治疗数据，以及 2027 年上半年 '0015 单药扩展和联合用药剂量递增数据（包括帕尼单抗），对于进一步验证至关重要。总体而言，ERAS 似乎处于有利地位，是一个资金充足、多适应症的注册故事，但我们认为，更多数据和更长的随访期仍将是关键。

近期更新（演示文稿在此）增强了 PDAC 疗效特性，但持久性数据仍不成熟。这些数据提供了仅限美国 2L+ 人群、采用 ≥8 周疗效可评估定义的逐次数据对比（4 月 vs. 5 月数据截止点）。uORR 在 24mg 剂量组从 14% 提升至 25%，在 32mg 剂量组从 50% 提升至 57%，在合并的 24-32mg RDE 组从 27% 提升至 40%。在美国 2L+ KRAS G12X PDAC 亚组中，32mg 剂量组的 uORR（≥8 周）为 57%（4/7），高于之前的 50%（2/4），因为该队列从 4 名可评估患者扩大到 7 名，应答人数从 2 人增加到 4 人。在合并的 24-32mg RDE 组中，活性从 27%（3/11）改善至 40%（6/15），所有应答者（已确认和未确认）均仍在接受治疗。剂量-反应趋势仍然明显（8/16/24/32mg 剂量组分别为 11%/0%/25%/57%），PK 数据显示剂量依赖性暴露，未观察到平台期。尽管如此，32mg 剂量组 57% 的 uORR 基于小样本量，且持久性随访有限，需要通过更多患者和更长随访期带来的更高一致性和应答深度来确认。

除非另有说明，所有指标均基于 MS ModelWare 框架 * = 基于共识方法 § = 共识数据由 Refinitiv Estimates 提供 e = MS 估计值

e = MS 估计值，a = 公司实际报告数据

MS 会并寻求与其报告所涵盖的公司开展业务。因此，读者应意识到，该公司可能存在利益冲突，可能影响 MS 的客观性。读者应将 MS 视为其研究决策中的一个单一因素。

有关分析师认证和其他重要披露，请参阅本报告末尾的披露部分。

图表 1：4 月和 5 月数据截止点下 2L+ KRAS G12X PDAC 患者的疗效数据

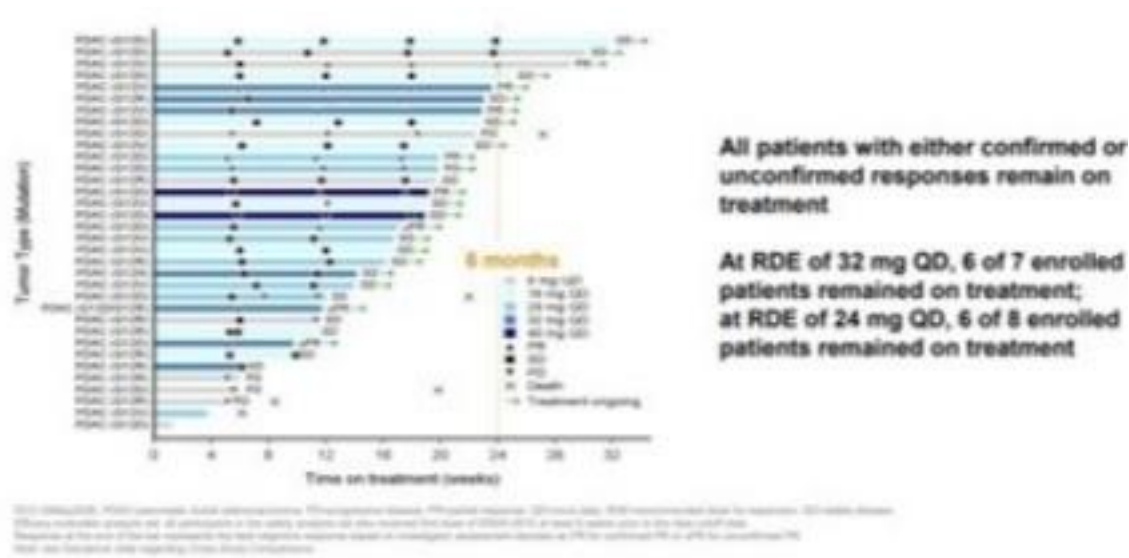
Patients who received first dose of ERAS-0015 at least 8 weeks prior to Apr 2026 DCO					
ERAS-0015 2L+ KRAS G12X PDAC ¹	8 mg QD N=9	16 mg QD N=6	24 mg QD N=7	32 mg QD N=4	48 mg QD N=2
uORR ² , n (%)	1 (11)	0	1 (14)	2 (50)	0
DCR, n (%)	4 (44)	5 (100)	5 (71)	4 (100)	2 (100)

Patients who received first dose of ERAS-0015 at least 8 weeks prior to May 25, 2026 DCO					
ERAS-0015 2L+ KRAS G12X PDAC ¹	8 mg QD N=9	16 mg QD N=6	24 mg QD N=7	32 mg QD N=7	48 mg QD N=2
uORR ² , n (%)	1 (11)	0	2 (25)	4 (57)	1 (50)
DCR, n (%)	4 (44)	5 (100)	6 (75)	7 (100)	2 (100)

图表 1

来源：公司报告

图表 2：2L+ KRAS G12X PDAC 患者更新的治疗持续时间



图表 2

来源：公司报告

图表 3：ERAS-0015 疗效 vs. 对照药物泛 RAS 分子胶 RMC-6236 基准



图表 3

图表 4：ERAS-0015 安全性 vs. 对照药物泛 RAS 分子胶 RMC-6236 基准 来源：公司报告

	ERAS-0015		RMC-6236				
	Ph 1 16-32 mg Apr 2020	Ph 1 16-32 mg 20 May 2020	Ph 1 280mg (ESMO 2022) ^a	Ph 1 160-300mg (SMA 2024) ^a	Ph 1 300mg (NEJM 2020) ^a	Ph 1 All doses (NEJM 2020) ^a	Ph 3 300 mg (NEJM 2020) ^a
n	43	72	111	127	63	168	241
All Grades							
Rash	81%	72%	81%	81%	80%	88%	80%
Diarrhea	30%	32%	30%	48%	52%	40%	38%
Stomatitis	18%	19%	22%	31%	34%	40%	33%
Nausea	12%	14%	48%	43%	30%	40%	47%
Grade 3+							
Rash	2%	2%	8%	8%	7%	7%	14%
Diarrhea	0%	1%	1%	2%	4%	3%	1%
Stomatitis	0%	2%	2%	2%	4%	4%	12%
Nausea	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
Dose Interruptions	12%	12%	-	34%	42%	37%	36%
Dose Reductions	7%	8%	14%	18%	30%	21%	30%
Dose Discontinuations	0%	0%	1%	0%	0%	1%	1%

^a Cell shading reflects the relative incidence of each adverse event within that AE category only; color intensity should not be compared across different AE categories.

Source: ERAS-0015, RMC-6236, and Ph3 RASolute 302. Percentages are based on the number of patients who received at least one dose of the study drug. Data are presented as n (%).

图表 4

来源：公司报告

安全性特征支持持续给药和联合用药潜力。在 16-32mg 剂量范围内，安全性数据库已扩大至 N=72（之前为 43 例）。皮疹发生率为 72%（包括 3% 的 3 级），腹泻为 32%（1% 为 3 级），口腔炎为 19%（3% 为 3 级）。剂量中断发生率为 13%，剂量减少为 8%，无 TRAE 相关的停药。常见毒性未见明确的剂量梯度，16/24/32mg 剂量组的皮疹发生率分别为 81%/75%/64%。所有剂量组的中位相对剂量强度（RDI）为 100%，24mg 组的平均 RDI 为 95.0%，32mg 组为 93.5%，合并组为 95.9%。与 daraxonrasib（RMC-6236）的跨研究比较表明，'0015 的 3 级以上皮疹和口腔炎发生率更低，剂量调整更少，但该比较跨越了不同的试验阶段和人群，且 '0015 的随访期仍较短。值得注意的是，每个项目均报告了一例 5 级肺炎事件：'0015 在 AURORAS-1 研究中（一例 3 级事件，在患者选择退出支持治疗后进展为 5 级），以及 daraxonrasib 在 Ph3 RASolute 302 试验中（0.4%）。我们认为这可能是一种类别相关不确定性，而非明确的分子特异性信号。

图表 5：按级别划分的最新版 ERAS-0015 安全性总结

Summary of TRAEs occurring in ≥10% of patients					
Patients with RASin NBCLC and PDAC Treated at PAD (16-32mg) ERAS-0015 (N=72)					
TRAEs, n (%)	Grade 1	Grade 2	Grade 3 ^a	Grade 4	All Grades
Rash ^b , n (%)	37 (51)	13 (18)	2 (3)	0	52 (72)
Diarrhea, n (%)	17 (24)	5 (7)	1 (1)	0	23 (32)
Stomatitis, n (%)	9 (13)	3 (4)	2 (3)	0	14 (19)
Nausea, n (%)	9 (13)	1 (1)	0	0	10 (14)
TRAEs leading to dose interruptions, n (%)					9 (13)
TRAEs leading to dose reductions, n (%)					6 (8)
TRAEs leading to dose discontinuations, n (%)					0

^a Grade 3+ includes Grade 3, 4, and 5 events. ^b Rash includes all grades of rash. ^c Diarrhea includes all grades of diarrhea. ^d Stomatitis includes all grades of stomatitis. ^e Nausea includes all grades of nausea. ^f TRAEs leading to dose interruptions include all grades of TRAEs leading to dose interruptions. ^g TRAEs leading to dose reductions include all grades of TRAEs leading to dose reductions. ^h TRAEs leading to dose discontinuations include all grades of TRAEs leading to dose discontinuations. ⁱ Data are presented as n (%).

图表 5

来源：公司报告

图表 6：按剂量划分的最新版 ERAS-0015 安全性总结

Summary of TRAEs occurring in ≥10% of patients				
Patients with RASm NSCLC and PDAC Treated at FMD (16-32mg) ERAS-0016 (N=72)				
TRAEs, n (%)	16 mg QD (N=16)	24 mg QD (N=28)	32 mg QD (N=28)	16-32 mg (N=72)
Rash ¹ , n (%)	13 (81)	21 (75)	18 (64)	52 (72)
Diarrhea, n (%)	5 (31)	11 (38)	7 (25)	23 (32)
Stomatitis, n (%)	4 (25)	5 (18)	5 (18)	14 (19)
Nausea, n (%)	3 (18)	3 (11)	4 (14)	10 (14)
TRAEs leading to dose interruptions, n (%)	1 (6)	6 (21)	2 (7)	9 (13)
TRAEs leading to dose reductions, n (%)	1 (6)	2 (7)	3 (11)	6 (8)
TRAEs leading to dose discontinuations, n (%)	0	0	0	0

¹ Rash severity was mild to moderate and included pruritus, dry skin, and redness. Rash was managed with topical corticosteroids and antihistamines. Rash severity was mild to moderate and included pruritus, dry skin, and redness.

图表 6

来源：公司报告

联合用药可行性正成为一个关键的差异化因素……

近期更新进一步支持了联合用药的论点，尤其是在耐受性方面。截至 7 月 6 日的数据截止点，'0015 16mg + 标准剂量帕尼单抗已通过初始剂量水平，在 4 名 DLT 可评估患者中未观察到 DLT。16mg 剂量组的回填和 24mg 剂量组的递增正在进行中。尽管除了之前报告的 uPR 外，没有额外的疗效披露，但我们认为，考虑到历史上与 RAS 联合策略相关的耐受性挑战，这代表了重要的一步。

……并且除了帕尼单抗，联合用药机会持续扩大。默克（由 Terence Flynn 覆盖）正在为 Erasca 申办的 AURORAS-1 研究提供帕博利珠单抗，而 Tango 将申办一项 '0015 + PRMT5i vopimetostat 在 MTAP 缺失型胰腺癌和 RASm NSCLC 中的 1/2 期研究。随着单药治疗数据集的成熟，我们将这些合作视为潜在机会的早期迹象。虽然 EGFR、PD-1 和 PRMT5 联合用药表明 '0015 有可能作为可联合的 RAS 骨架，但我们认为即将公布的联合用药数据对于确立疗效、耐受性、剂量强度和可联合性的平衡，并最终支持更差异化的定位至关重要。

路径更清晰，但取决于监管协调与执行。除了现有数据外，注册策略的进一步明确也支撑了前景。公司计划在 2027 年上半年启动一项可能支持注册的 2L+ NSCLC 研究，随后在 2027 年启动一项 1L PDAC III 期研究，并在 2027 年下半年至 2028 年上半年启动一项 RASm NSCLC 关键性 III 期研究。如果执行顺利，这将使 '0015 在大约 18-24 个月内从早期临床开发进入三个注册导向项目。这一顺序看起来合乎逻辑，NSCLC 通过更清晰的单药治疗路径领先，而 PDAC 则推进至更前线治疗，在此线别中，耐受性和联合用药的灵活性可能更具影响力。公司还宣布了一项扩大规模的公开发售，总募资额达 6.325 亿美元，这应能支持平行注册开发。尽管如此，执行仍取决于监管协调和试验的及时启动，特别是首个 NSCLC 研究预计将在即将公布数据更新的相近时间窗口内开始。综合来看，所概述的路径是明确且有资金支持的，但我们承认仍需持续的监管明确性和运营执行力。

知识产权（IP）悬而未决，缓解路径依赖于数据。在知识产权方面，我们仍然认为，如果临床差异化得以持续，当前估值折价存在可信的缩小路径，尽管我们并不认为该不确定性在当前阶段已得到解决（参见我们此前发布的评估专利侵权不确定性的分析）。Revolution Medicines（RVMD，未覆盖）的主张依赖于等同原则而非字面侵权，我们之前的分析表明，在此框架下成功主张的先例有限，尽管样本量较小。更重要的是，在剂量、PK/PD、疗效、安全性、剂量强度及联合用药方面的持续差异化，可能日益支持关于功能-方式-结果及非实质性差异的论点。尽管如此，这需要随着时间的推移形成更成熟且明确差异化的临床特征。总体而言，我们认为 '0015 疗效和安全性特征的持续增强，可能使其能够随着时间的推移在很大程度上缓解知识产权悬而未决的问题，尽管需要更多数据来确认这一趋势。

不确定性回报平衡，有明确路径可转向更具建设性的立场。尽管不确定性依然存在，包括 PDAC 中 32mg 剂量组样本量小、耐久性数据不成熟、联合用药数据在演变，以及对监管协调和试验执行的依赖，但我们认为这些问题可以通过持续的数据生成来解决。

重要的是，近期在疗效一致性、新兴联合用药可行性、更清晰且加速的注册策略、外部验证以及有资金支持的开发计划方面取得的进展，逐步改善了不确定性回报。要让我们对该股变得更加看好，我们需要看到几个关键的门槛因素：（1）更长的随访时间以确立耐久性，（2）更大且更具代表性的患者数据集以确认应答的一致性，以及（3）按照所概述的注册路径持续执行试验启动和患者入组。这些要素的实现，特别是更成熟的数据和进入注册导向研究，可能支持将NSCLC和PDAC的成功概率从50%提高至60%，这更符合我们对注册阶段项目的阈值。

模型更新：我们将ERAS-0015/ERAS-4001在PDAC中的成功概率从40%上调至50%，在NSCLC中从35%上调至50%，在CRC中从35%上调至45%，这反映了信心的增强、开发路径的加速以及更受验证的RAS靶向格局。我们将假设的NSCLC上市时间提前一年至2030/2031年，现在模型假设1L/2L PDAC在2030年同时上市，将总价假设从3万美元上调至4万美元以反映溢价定位，并相应调整了销售成本、销售及管理费用以及研发费用。对于'0015/'4001，我们现在模型预测未经调整的峰值销售额约为36亿美元（不确定性调整后约18亿美元），而市场预期在PDAC中约为40亿美元（不确定性调整后约16亿美元）；在NSCLC中，未经调整的峰值销售额约为24亿美元（不确定性调整后约12亿美元），而市场预期约为23亿美元（不确定性调整后约8亿美元）；在CRC中，未经调整的峰值销售额约为9.2亿美元（不确定性调整后约4亿美元），而市场预期约为17亿美元（不确定性调整后约6.3亿美元）。我们还纳入了近期扩大规模的公开发行，包括增加的现金及相关的稀释效应。。

相关研究：公司情况更新

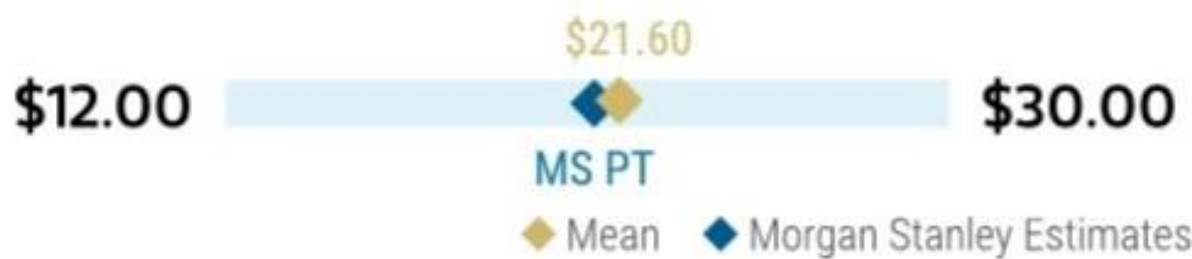
- 生物技术：2026年ASCO RAS肿瘤学工具包：您需要了解的内容（2026年5月29日）
- Erasca,Inc.：评估ERAS-0015的专利侵权不确定性（2026年5月26日）
- 生物技术：来自我们KOL电话会议的要闻：近期RAS数据更新（2026年5月17日）
- Erasca,Inc.：ERAS-0015初步I期数据可能具有说服力——等待成熟（2026年4月28日）
- 生物技术：来自我们KOL电话会议的要闻：RAS靶向药物（2026年3月2日）
- 生物技术：来自我们KOL电话会议的要闻：RAS靶向格局（2026年2月20日）

不确定性回报 – Erasca,Inc. (ERAS.O)

ERAS-0015 和 ERAS-4001 驱动不确定性/回报

公司情况更新

，假设折现率为15%，终值增长率为2.5%。



图表 7

不确定性回报图



图表 8

来源：Refinitiv, MS

公司观点观点

我们对ERAS-0015初步展现的临床特征、潜在的联合用药机会以及加速注册路径的可能性感到鼓舞，但期待在即将到来的更新中看到更大患者数据集以进行进一步验证。我们也期待ERAS-4001的更新以及naporafenib的潜在合作机会。我们认为，由于该公司的资产（“RAS肿瘤学”）具有潜在的战略价值，ERAS的报价可能继续以高于公允价值的价格交易。



图表 9

不确定性回报主题

颠覆：此处为不确定性回报主题的正面观点描述

牛市情景 32.00 美元 基准情景

DCF：公司情况更新

ERAS-0015 和 ERAS-4001

报告的数据优于预期，导致更高的成功概率和峰值市场份额。我们对naporafenib模型采用更高的成功概率。

DCF：公司情况更新

ERAS-0015 和 ERAS-4001
的数据支持在RASm实体瘤和KRASm实体瘤中继续推进。我们对naporafenib模型采用利润分成。

21.00 美元 熊市情景

DCF：公司情况更新

2.00 美元
数据和更新令人失望，限制了商业化。ERAS报价跌破现金价值。
平均MS估计 来源：Refinitiv, MS

不确定性回报 – Erasca,Inc. (ERAS.O)

关键盈利输入

研究驱动因素

- ERAS-0015 I期AURORAS-1数据
- ERAS-4001 I期BOREALIS-1数据

全球收入敞口



图表 10

来源：MS估计 在此处查看区域层级解释

MS ALPHA模型

来源：Refinitiv, FactSet, MS；1为最高偏好五分位，5为最低偏好五分位

公司情况更新

上行不确定性

- 积极的ERAS-0015和ERAS-4001临床数据
- 快于预期的监管路径
- 令人鼓舞的naporafenib合作更新

节奏变化不确定性

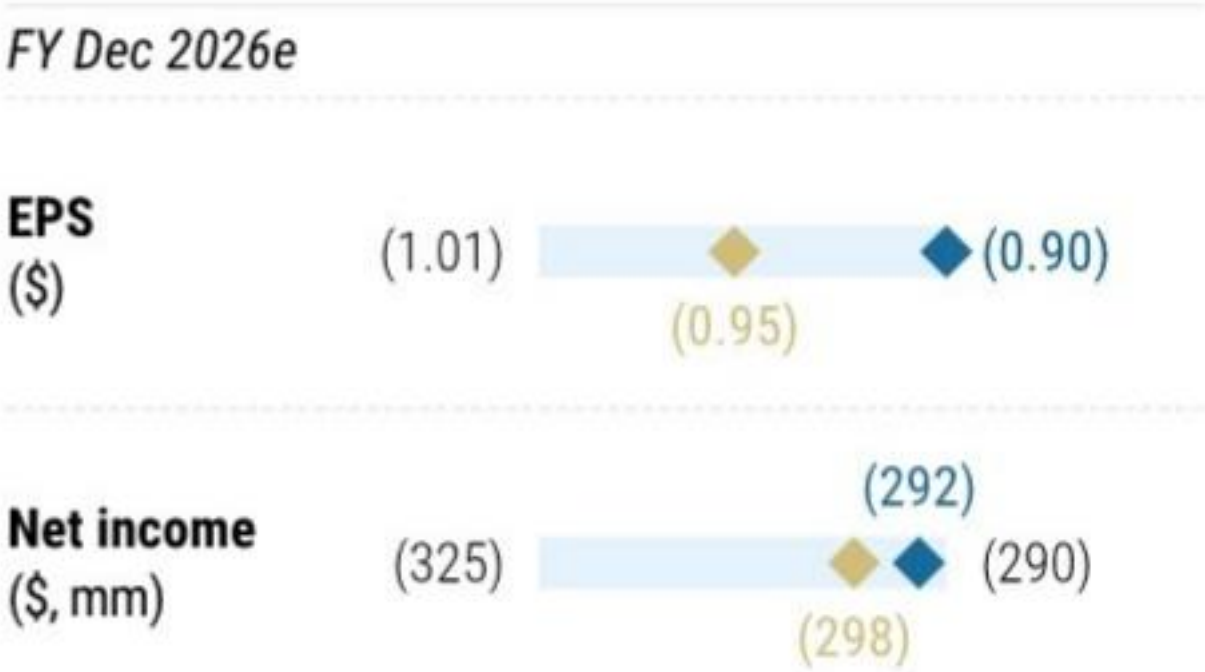
- 令人失望的ERAS-0015和ERAS-4001临床数据
- 监管路径慢于预期

\- 令人失望的 naporafenib 合作进展

持仓定位：公司情况更新

Refinitiv；MSPB 内容。包含部分与 MSPB 持有的对冲产品敞口。信息可能与更广泛的市场趋势不一致或无法反映该趋势。多空比 = 多头敞口 / 空头敞口。行业占净敞口总额百分比 = (特定行业：多头敞口 - 空头敞口) / (所有行业：多头敞口 - 空头敞口)。

MS预估 vs. 市场共识



图表 11

不确定性收益参考链接

- 查看期权概率方法论说明 - Options_Probabilities_Exhibit_Link.pdf
- 查看不确定性收益主题说明 - RR_Themes_Exhibit_Link.pdf
- 查看区域层级说明 - GEG_Exhibit_Link.pdf
- 查看主题/敞口方法论说明 - ESG_Sustainable_Solutions_External_Link.pdf
- 查看 HERS 方法论说明 - ESG_HERS_External_Link.pdf